

Asignatura: Salud del niño, niña y adolescente

SEMINARIO

Guia para el Estudiante



ENCUENTRO : ATENCIÓN INTEGRAL DEL LACTANTE

-Contenidos: Atención integral del lactante. Historia clínica, examen físico completo, desarrollo madurativo, PRUNAPE, inmunizaciones, recomendaciones, evaluación oftalmológica y auditiva del lactante.

Fecha : 6 de abril 2026

Objetivo general:

- Abordar la consulta integral de los niños y niñas menores de 2 años.

Objetivos específicos

- Abordar las problemáticas de la atención de la salud desde la perspectiva de la semiología, de variantes de la normalidad de los signos y síntomas de alarma y la derivación oportuna.
- Conceptualizar la Historia Clínica como la herramienta fundamental con énfasis en la anamnesis, la semiología y el examen físico.
- Realizar una correcta evaluación de los datos antropométricos (peso, talla y PC) y saber utilizar las tablas de percentilos.
- Evaluar el desarrollo madurativo del lactante y conocer la PRUNAPE .

- Realizar derivaciones oportunas a especialistas (control oftalmológico, auditivo, odontológico, etc)
- Desarrollar habilidades de comunicación para brindar información adecuada y oportuna sobre la situación de salud del niño o niña menor de 2 años (alimentación, suplementación, pantallas, accidentes, inmunizaciones, etc)

Bibliografía general Módulo Atención integral :

- 1) Cotrofe JM, Piamonti KA, Murray M C, Neme M L, Gaudio R. La salud integral del niño, niña y adolescente (SANNA). En: Reichenbach JA et al, editores. La RED SaNNA Salud del Niño, Niña y Adolescente con perspectiva de derecho. 1er Edición. 2021. p. 70-107.
- 2) Calendario Nacional de Vacunación de Argentina 2026 disponible en:
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2026-03-10_calendario_nacional_vacunacion_70x50_web.pdf
- 3) Suárez Cuba MG. El Genograma: herramienta para el estudio y abordaje de la familia. Rev Med La Paz, 2010; 16(1): 53-57.
- 4) Cuneo C, Vázquez J., Sequeiros ML, et al, Control de salud en el Primer Año de vida. En: Reichenbach JA et al, editores. La Hora de Oro en Pediatría. vol 1. 1er Edición. La Plata: Fundación Femeba; 2018. p. 135-163
- 5) Dra. Marta Gómez Fernández-Vegue Comité de Lactancia Materna y Comité de Nutrición de la Asociación Española de Pediatría. Guías de alimentación complementaria: Asociación Española de Pediatría. nov 2018
- 6) Álvarez N, Carmona C, García C, Herrera Arévalo V, Lamberto M, Orellana F, Rodríguez A, Saidman G. Control oftalmológico en pediatría. En: Reichenbach JA et al, editores. Pediatría en red 4. 1er edición. 2022. P. 269-272
- 7) Morano J., Reichenbach J. Historia clínica y exploración física. Capítulo 2. p 15- 27
- 8) Aquino C, Querejeta M. Desarrollo psicomotor infantil: la importancia de su evaluación en la consulta de niño/a sano. Pediatría en Red 6. Núcleo 3. P 843- 848
- 9) Video desarrollo realizado por la asignatura (prunape y desarrollo infantil)
- 10) Curvas de crecimiento. Libro verde de la SAP.

Traer impreso y resuelto con los datos de los casos clínicos.

- la historia clínica (Morano) para llenar los datos de los casos clínicos,
- las curvas de crecimiento qué están al final de la guía (libro verde SAP)
- la de PRUNAPE

Preguntas generales para responder ANTES de ir al seminario:

1. ¿En qué consiste el examen clínico integral en el control de salud del lactante? ¿Qué edades comprende un lactante? ¿Cuál es la periodicidad de los controles de salud?
2. ¿Cuál es la importancia de la evaluación del desarrollo infantil? ¿Qué significa PRUNAPE?
3. ¿Cuáles son las pautas de alarma del examen físico y cual es su conducta según edad?
4. Con respecto a las recomendaciones de la alimentación, ¿a qué edad se inicia y qué se aconseja dar según la edad de cada niño?
5. ¿Cuáles son las vacunas recomendadas en el periodo del lactante?
6. ¿Cuándo se recomiendan los suplemento de hierro y vitamina D? ¿Por qué? ¿Cuáles son las dosis?
7. ¿Cuáles son las recomendaciones que daría a madres y padres de lactantes?
8. ¿Cómo es la evaluación oftalmológica y auditiva del lactante?

SITUACIÓN CLÍNICA N° 1

Camila tiene 6 meses y concurre a control de salud. Sus controles previos fueron realizados en Ushuaia y por trabajo paterno se mudaron a Mar del Plata hace 3 meses. Trae su libreta de vacunas y controles previos.

Su mamá, Juana de 35 años, le cuenta que tiene 3 hijos más con Alberto de 40 años, Carolina de 8 años, Felipe de 5 años y Pablo de 3 años. Alberto tiene 3 hijos de un matrimonio anterior: Julia 16 años, Pedro 13 años y Pilar 11 años que viven en Ushuaia con su mamá.

Abuela materna de 60 años con asma y sufrió un infarto hace 2 meses. Abuelo materno fallecido a los 60 años, por DBT hace 5 años. Abuelo paterno de 65 años que se encuentra en control por cáncer de próstata y recibe tratamiento quimioterápico y Abuela paterna fallecida a los 60 años de edad, por Edema agudo de pulmón hace 2 años.

Felipe sufre broncoespasmos a repetición y está en seguimiento por Neumonología.

Alberto es asmático, de chico sufrió varias internaciones por ese motivo. Trabaja en la marina. Fuma y consume alcohol diariamente un vaso. Juana es ama de casa.

Carolina va a 3 grado y sus hermanos van al jardín.

Viven en un departamento de 2 ambientes con cloacas, agua potable y luz, con un gato que nunca recibió tratamiento antiparasitario.

Camila nació de un embarazo deseado, controlado, con un peso de 3 Kgs, T: 48 cm PC 34 cm. EG 39 sem. Cesárea por elección para ligadura de trompas.

Camila presentó una internación a los 3 meses por Bronquiolitis donde estuvo en terapia intermedia, permaneció por 7 días. Luego fue medicada con Budesonide profiláctico que utiliza hasta ahora.

Otoemisiones acústicas, FO y pesquisa neonatal normal. Rx caderas 5 meses normal. se alimenta con lactancia materna.

Duerme sola en su cuna y hace 2 o 3 despertares en la noche para tomar la teta. Hace caca cada 3 o 4 días, eso a Juana le preocupa, de consistencia normal y color amarillo-mostaza.

Refiere que es una nena muy inquieta, que se lleva todo a la boca, hasta sus pies. Se chupa las manos y a veces genera arcadas. Pasa objetos de una mano a la otra. Se

sienta sola. Rola de boca arriba a boca abajo. Le gusta que le canten y le hablen. Y su actitud frente al espejo es de reconocimiento. Grita y se calma cuando mira y escucha la voz de mamá. Sonríe y se ríe a carcajadas.

Cuando le pregunta por las vacunas, Juana le cuenta que no ha podido colocar algunas, en la libreta figuran colocadas: Hep B y BCG, 1 dosis de pentavalente (3m), 1 menveo (3m), VPI 1 dosis (3m), neumococo 1 dosis (3m)

Controles previos:

-5 semanas de vida: 3.750grs / T 53 cm/ PC: 36 cm

-3 meses: 5.250 grs/ T 59 cm/PC: 39 cm

-4 meses y medio: 6, 250 grs/ T 63 cm/ PC 41 cm

Examen físico:

P: 7 Kg T: 66 cm PC: 42 cm

Buen estado general. Fontanela anterior puntiforme, buena fijación y seguimiento de ambos ojos, responde a diferentes sonidos

Presenta 1 incisivo inferior

R1 y R2 normofonéticos en 4 focos, silencios impresionan libres

Pulsos radiales y femorales presentes y simétricos

Sin organomegalias

Genitales femeninos sin fusión de labios.

Columna alineada

Realiza trípode rola y sedesta sin ayuda por momentos, permanece en su alfombra en el piso varias horas del día.

1 Describa detalladamente los datos relevantes del relato. Complete la historia clínica de Camila

2 Realice el genograma

3 Describa partes del examen físico y aspectos generales del desarrollo (4 áreas) Utilice la tabla de la PRUNAPE

4-Realice antropometría: Utilice las curvas de percentilos de la OMS para colocar todos los datos de peso, talla y PC.

5 ¿Cuáles son las recomendaciones para iniciar la alimentación en un lactante de 6 meses? Indique suplementos de vitamina D y hierro.

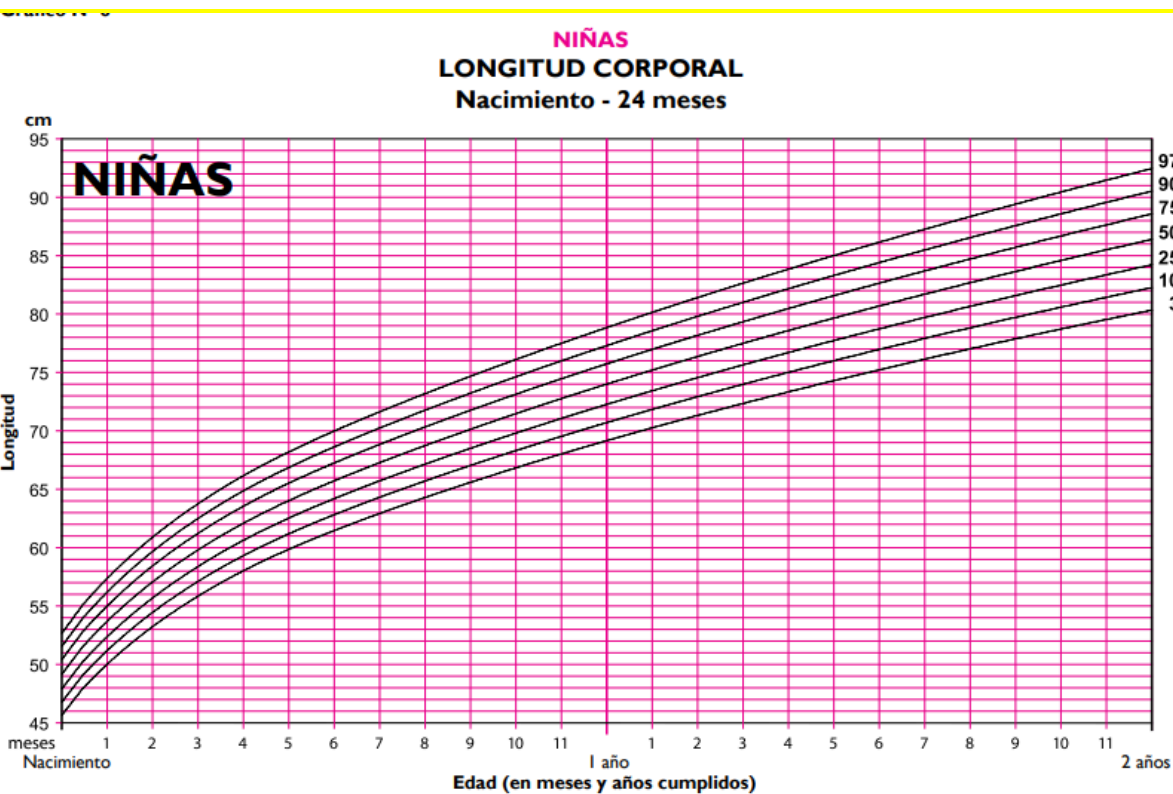
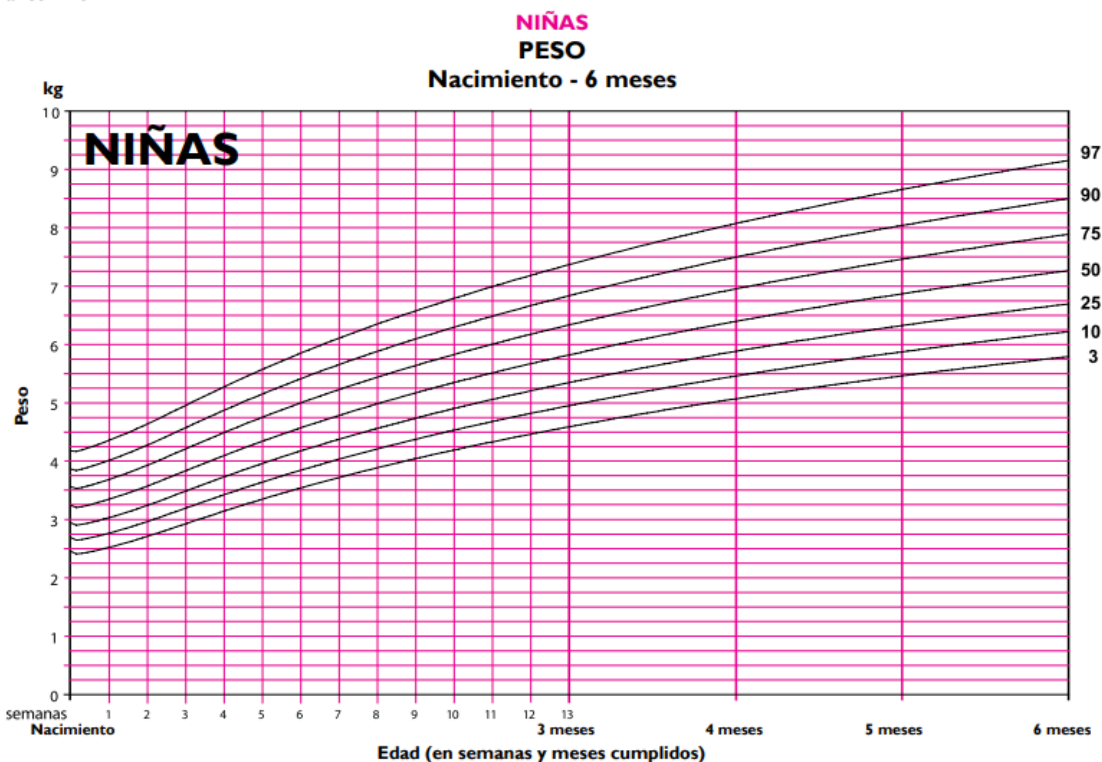
6 ¿Cuáles son las vacunas recomendadas según edad?

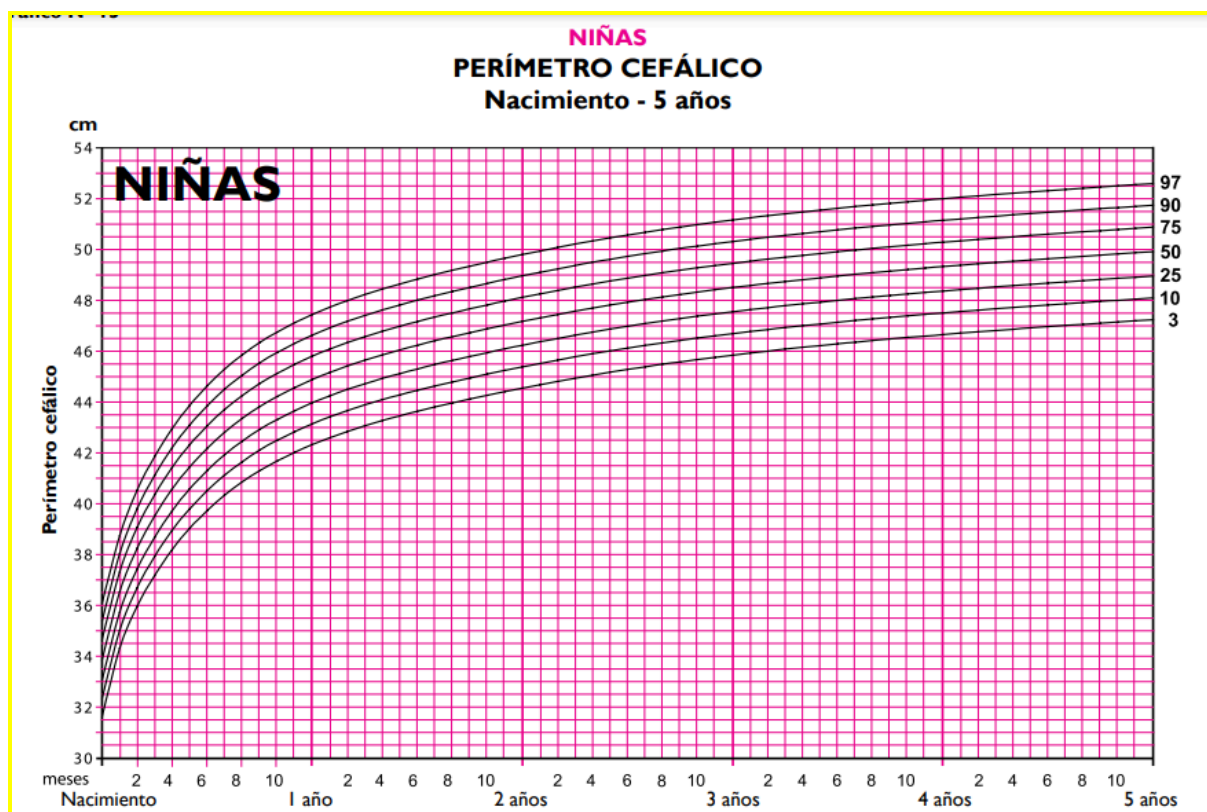
7 En el cierre de la consulta cuales son las recomendaciones qué da

Gráfico N° 3

38

Sociedad Argentina de Pediatría • Comité Nacional de Crecimiento y Desarrollo





SITUACIÓN CLÍNICA Nº 2

Sebastián de 16 meses

Es traído a la consulta por su padre Marcos de 27 años es maquinista en una empresa. Miranda, su madre de 25 años se encuentra trabajando actualmente de enfermera. Ellos están sanos. La abuela materna de 52 años tiene antecedentes de tuberculosis con tratamiento finalizado hace 10 años, su abuelo materno de 55 años tiene Epoc y es fumador de un paquete diario.

Miranda tiene un hermano de 20 años sano y una hermana de 15 años con antecedentes de atopia.

Los abuelos paternos fallecieron en un siniestro de tránsito hace 4 años. Marcela tenía 49 años y Roberto 52 años. Ambos estaban sanos.

Sebastian nació de un embarazo controlado, por parto vaginal, con una EG de 38 semanas, un Peso nacimiento de 3150 gr, Talla 50 cm y PC 35 cm.

Pesquisa neonatal normal, OEA y FO normales

Rx de cadera normal (5 meses)

Vacunas completas hasta los 12 meses inclusive.

A los 13 meses presentó traumatismo de cráneo leve sin pérdida de conciencia, concurrió a la guardia, le realizaron examen físico completo, le dieron pautas y control en 24 hs con su pediatra. No presentó complicaciones

Viven en una casa en el mismo terreno que los papas de Miranda, tienen gas envasado y pozo de excretas.

Sebastian ingresa al consultorio del CAPS caminando y sonriente, en búsqueda de varios juguetes que observa desde lejos

Su padre comenta que el niño se alimentó con pecho exclusivo hasta los 6 meses y luego comenzó con semisólidos, actualmente suele estar negativista con los alimentos que antes

aceptaba, evita las verduras, complementa con 2 mamaderas (200 ml) por día, sus padres cepillan sus dientes una vez al día.

Duerme con sus padres y apenas lo quieren colocar en la cuna llora en forma intensa

Diuresis sin particularidades y catarsis diaria.

Previa explicación comienza el examen físico

Cabeza: fontanela cerrada

odontológico 2 dientes incisivos arriba y 4 abajo

Piel y mucosas rosadas

Examen ocular adecuado, sin signos de estrabismo

Ap cardiovascular R1 y R2 en 4 focos, sin soplos

Ap respiratorio sin ruidos agregados

Abdomen sin visceromegalias

Pulsos femorales y radiales presentes y simétricos

Testículos en bolsa, fimosis

Columna alineada extremidades simétricas

Camina solo con gran rapidez, se levanta sin sostén del piso, también combina el gateo para el desplazamiento

Lenguaje dice agua, y se hace entender por gestos y entiende órdenes simples, juega con sus padres en la consulta, y ofrece juguetes cuando se le pide

Actualmente (16 meses): Peso 10,500 kg, Talla 80 cm, PC 47 cm

Datos previos

9 meses 8,5 kg talla 72 cm Pc 44,5 cm

12 meses: 9,5 Kg talla 76cm, PC 45,5 cm

- 1. Describa detalladamente los datos relevantes de la historia clínica. Complete la historia clínica.**
- 2. Realice el genograma**
- 3. Describa cómo realizaría el examen físico y qué aspectos generales del desarrollo evaluaría (4 áreas). ¿Qué datos positivos rescata de esta evaluación de Sebastian? Utilice la tabla de la PRUNAPE**
- 4. Realice antropometría: Utilice las curvas de percentilos de la OMS para colocar todos los datos de peso, talla y PC**
- 5. Cuáles son las recomendaciones en la alimentación en un lactante de 16 meses**
- 6. Indique vacunas para edad**
- 7. En el cierre de la consulta cuáles son las recomendaciones qué da.**

Gráfico N° 30

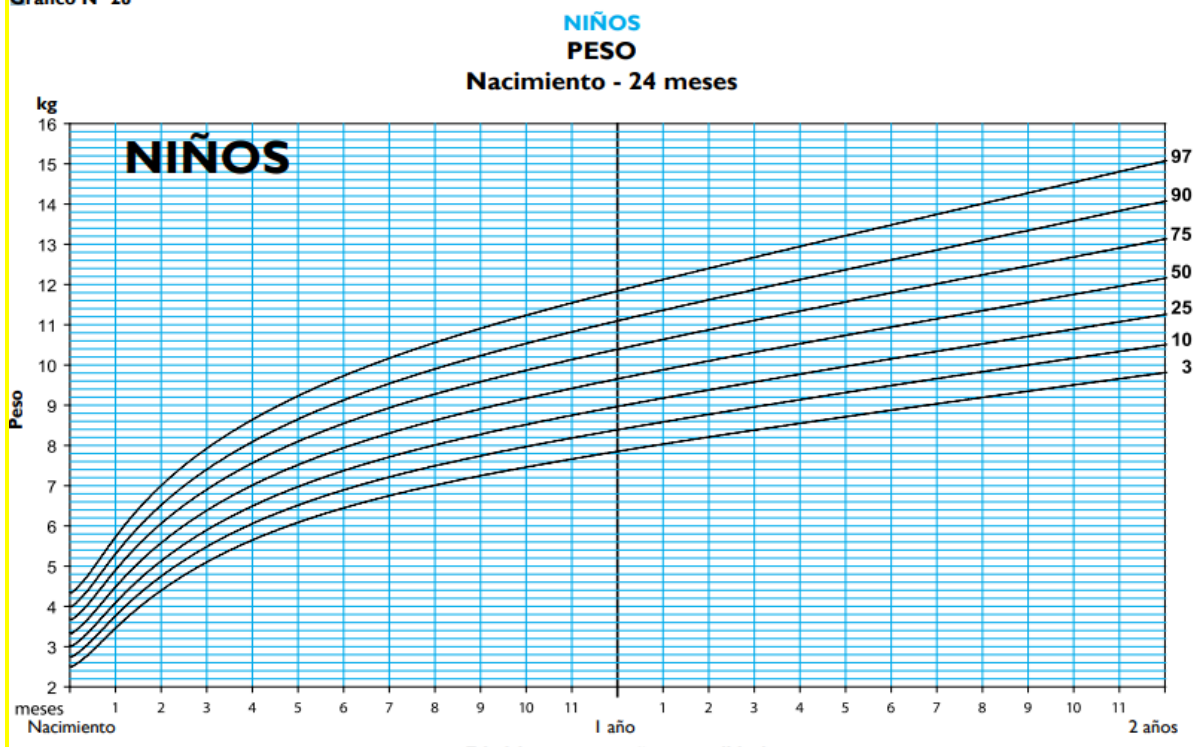
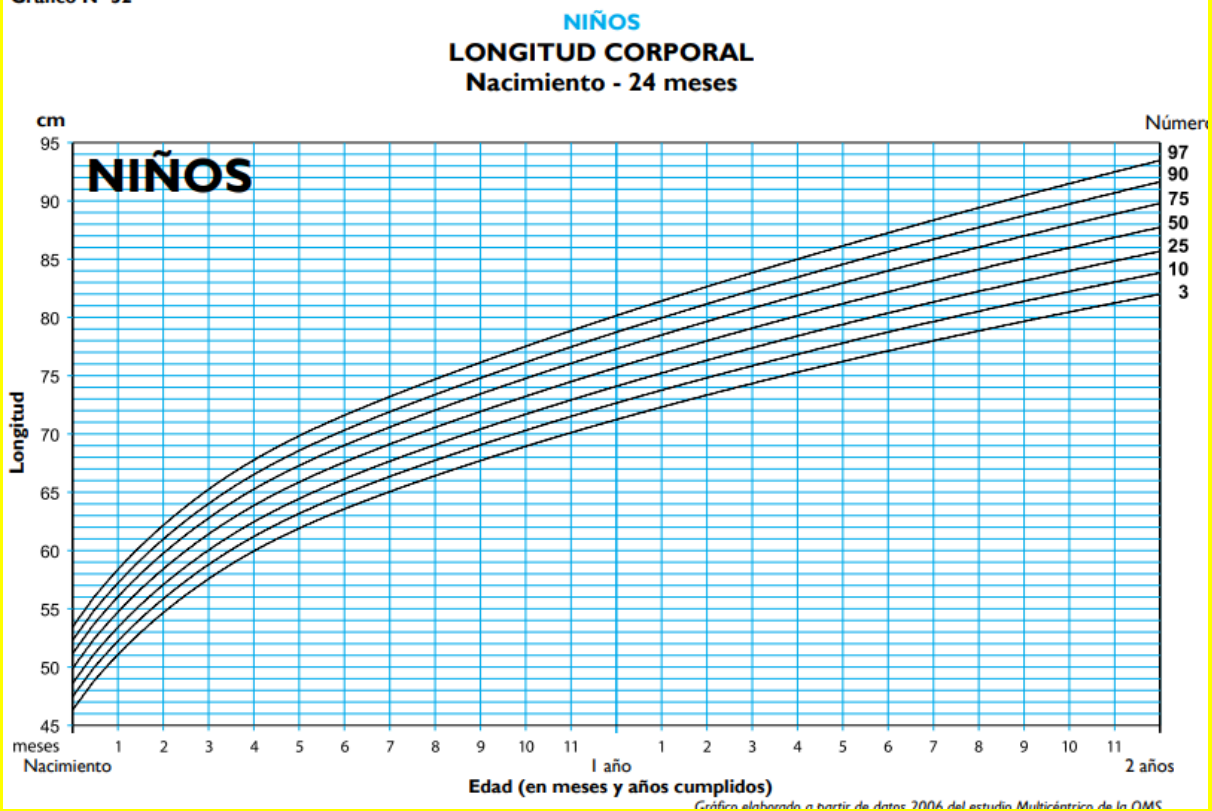
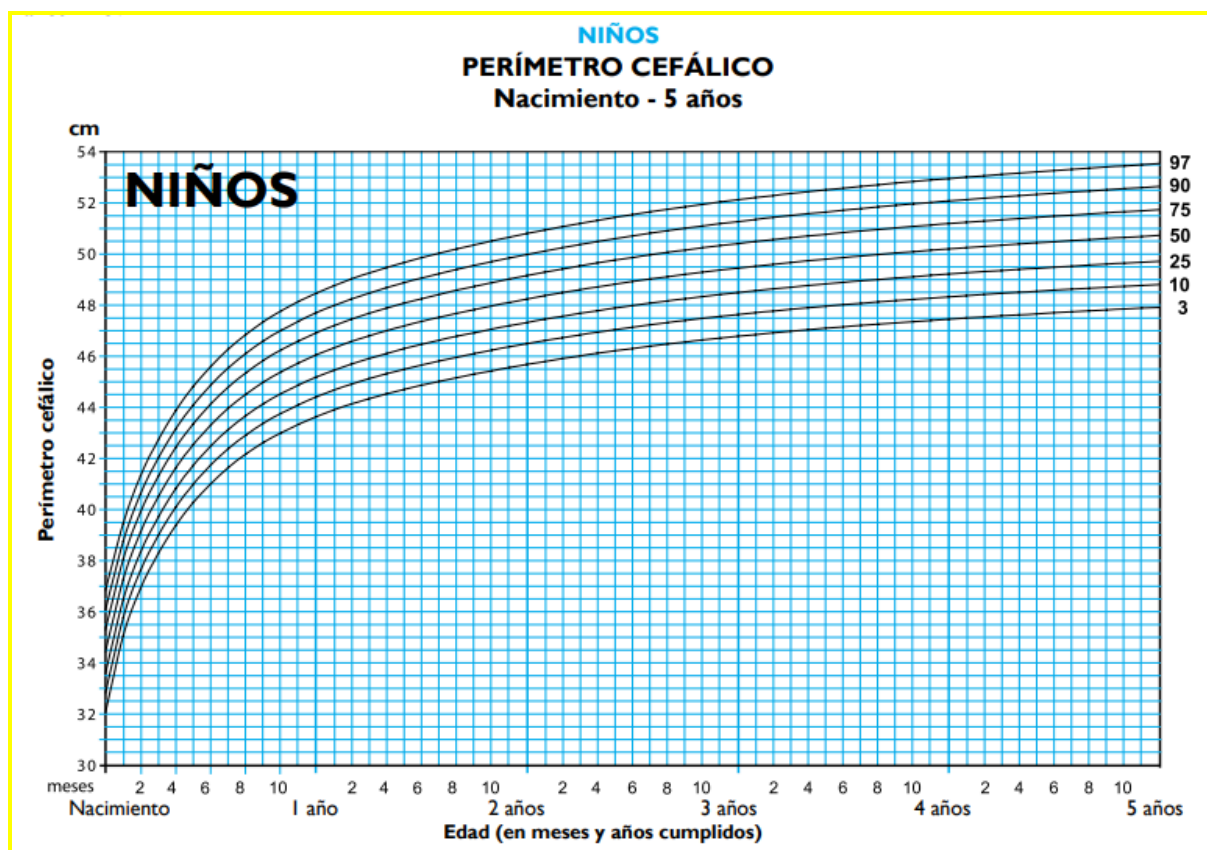
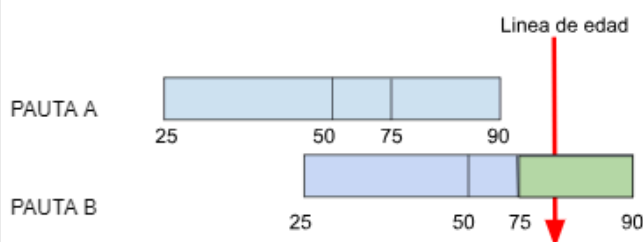


Gráfico N° 32





Pautas A ubicadas a la izquierda de la línea de la edad
Pautas B pautas en que la línea de la edad pasa por el rectángulo sombreado entre percentil 75 y 90
Pasa la prueba No debe haber fracasos de pautas A , puede existir un fracaso de pauta B en toda la prueba (Continúa con controles pediátricos de rutina)
No pasa la prueba (sospechoso o de riesgo) si fracasa en una pauta A o en 2 B (Repite prueba en 15 días) tampoco pasa la prueba si el niño se rehúsa a realizar las pautas



RECORDAR

Pasa la prueba No debe haber fracasos de pautas A , puede existir un fracaso de pauta B en toda la prueba (Continúa con controles pediátricos de rutina)

No pasa la prueba (sospechoso o de riesgo) si fracasa en una pauta A o en 2 B (Repite prueba en 15 días) tampoco pasa la prueba si el niño se rehúsa a realizar las pautas .Cada pauta puede administrarse 3 veces no aprobando si luego de los 3 intentos no la realiza

Recomendación para realización de prunape

Niño de bajo riesgo 1 3 y 5 años

Niños con factores de riesgo 6 meses, 1, 3 y 5 años.

Indicar pautas A para la edad:

PRUEBA NACIONAL DE PESQUISA - PRUNAPE

Formulario de Aplicación

Examinador/a:

Fecha de Nacimiento:/...../.....
..... día mes año

Nombre del niño/a:

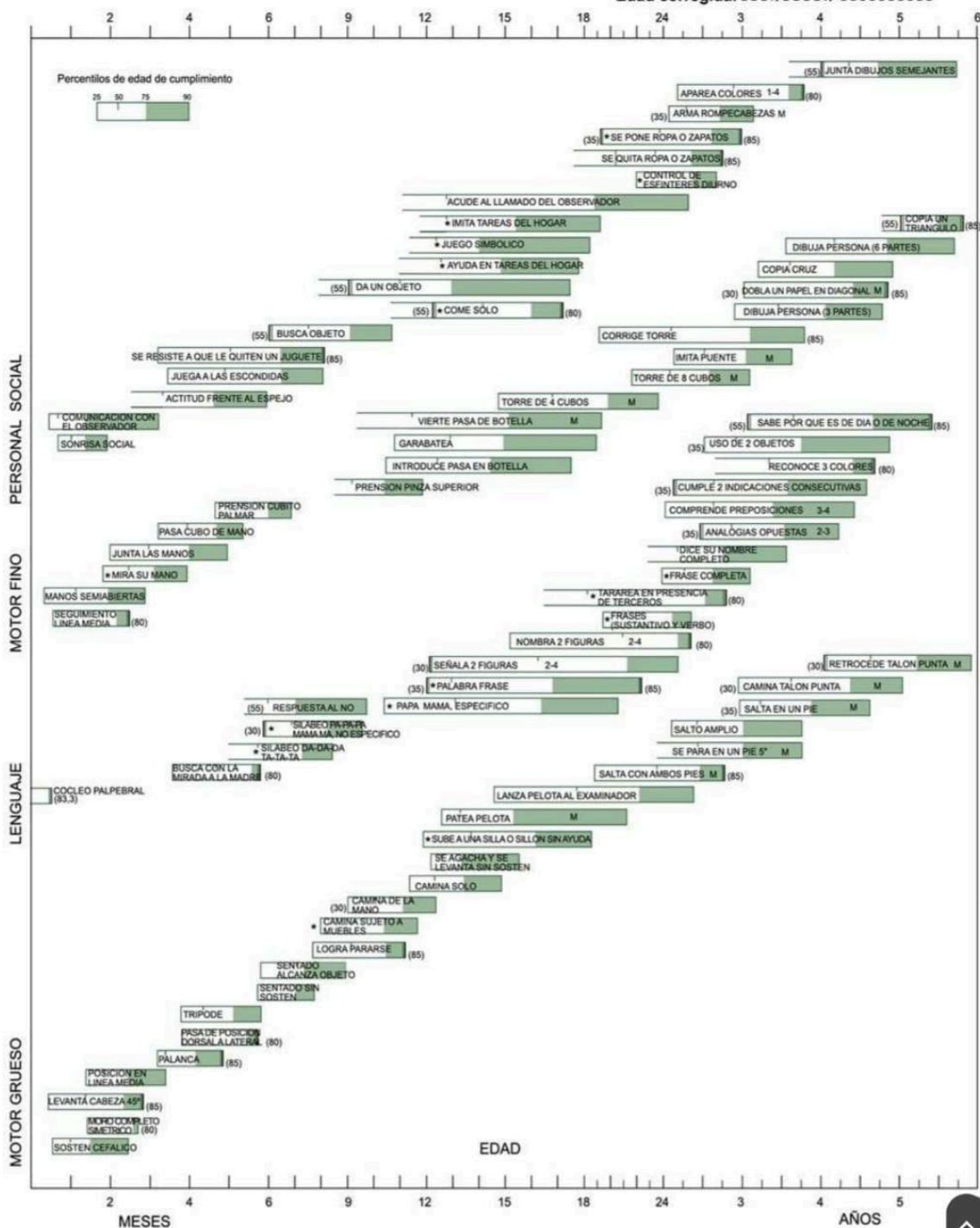
Fecha de la Pesquisa:/...../.....

Nº de H. Clínica:

Edad postnatal: años meses días

Edad gestacional (semanas):

Edad corregida:/...../.....



PROFILAXIS

Las conductas preventivas que pueden aplicarse están en relación con las condiciones biológicas, ambientales y socioeconómicas de la madre y el niño. Comprenden varios aspectos:²²

a. Conductas perinatales

- Sostén de la adecuación del hierro corporal en la embarazada.
- Incremento del hierro de depósito al nacer. Se recomienda la ligadura tardía del cordón umbilical (1-3 minutos luego del nacimiento), con lo cual se logra aumentar los depósitos de hierro corporal en, aproximadamente, 30% y disminuir la incidencia de anemia ferropénica.⁶⁴⁻⁶⁷ Se debe tener en cuenta que los riesgos de hiperbilirrubinemia y de síndrome de policitemia/hiperviscosidad en el neonato, así como los de hemorragia posparto grave en la madre, no han sido aún suficientemente evaluados.^{66,67}

TABLA 12. Dosis profilácticas de hierro para administrar en los distintos grupos de riesgo

Grupo	Dosis	Inicio	Duración
RN de término	1 mg/kg/día	2 meses	Hasta los 12 meses
RN pretérmino (1500-2000 g)	2 mg/kg/día	1 mes	Hasta los 18 meses
RN pretérmino (750-1500 g)	3-4 mg/kg/día	Durante el primer mes	Hasta los 18 meses
RN pretérmino (< 750 g)	5-6 mg/kg/día	Durante el primer mes	Hasta los 18 meses
RN con bajo peso de nacimiento	1-2 mg/kg/día	Durante el primer mes	Hasta los 12-18 meses
Mujeres adolescentes	60-80 mg/día	Durante 3 meses consecutivos por año	
Adolescentes embarazadas	60 mg/día	Al comienzo del 2º trimestre	Hasta el final del embarazo

RN: recién nacido.

Discusión y conclusiones

Dada la enorme incidencia del déficit de vitamina D en la población y el nuevo conocimiento comprobado o posible de consecuencias de esta deficiencia, la AAP aumentó la sugerencia del aporte de vitamina D a 400 UI/día desde los primeros días de vida, y continuar durante toda la infancia, a todos los chicos alimentados con lactancia materna, aunque recibieran además fórmula.

Para los chicos que no estuvieran alimentados con leche materna e ingirieran menos de 1 litro de leche por día, recomendaron también el suplemento de 400 UI/día. Para embarazadas y madres en lactancia, con la evidencia de los datos mencionados en el texto, sugirieron un aporte de, al menos, 1000 a 2000 UI/día. ■